Чудо в животике: многоплодная беременность.

Иногда в организме женщины зарождается две, а то и больше жизней. Разумеется, будущие родители бывают очень рады такому пополнению в семье, и вместе с тем у них возникает масса вопросов. **В этом номере журнала мы попробуем разобраться в теме многоплодной беременности , а поможет нам врач акушер-гинеколог Клиники «9 месяцев» Садриева Альбина Хайдаровна.**

Многоплодная беременность — это беременность, при которой в полости матки развивается два и более плода. Наибольшее число плодов было зафиксировано в 1946 году. В Бразилии женщина родила 10 малышей! По статистике вероятность наступления многоплодной беременности при естественном зачатии составляет совсем немного – 1,5-2 %.



Почему так происходит?

Рассмотрим факторы, которые повышают вероятность наступления многоплодной беременности.

1. **Наследственность.**

Многоплодная беременность чаще встречается в семьях, где мать или отец, или оба супруга произошли из двойни. Также вероятность возникновения многоплодной беременности возрастает через поколение.

2. **Множественная овуляция.**

Овуляция иногда происходит одновременно в двух яичниках. В одном яичнике может созревать два и более фолликула, а в одном фолликуле может быть несколько яйцеклеток. Это в 10 раз повышает вероятность рождения близнецов.

3. **Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).**

В настоящее время число многоплодных беременностей возросло, конечно, и связано это с широким применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, гиперстимуляции овуляции). Так, если частота возникновения многоплодной беременности без вмешательств составляет 1-2%, то при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) — до 40% .

4. **Возраст мамы более 35 лет.**

У женщин 35-40 лет увеличивается секреция фолликулостимулирующего

гормона, который способствует множественной овуляции.

Чем отличаются близнецы от двойняшек?

Близнецы бывают однояйцевые и разнояйцевые. В чем же отличия?

Однояйцевые близнецы — результат деления одной оплодотворённой клетки, после чего каждая из новых клеток развивается в зародыш.

Разнояйцевые близнецы развиваются из двух и более яйцеклеток, оплодотворённых разными сперматозоидами.

Таким образом, в медицине нет понятия «двойняшки». В народе этим термином называют разнояйцевых близнецов. Однояйцевые близнецы всегда однополые, имеют одну группу крови, одинаковый цвет глаз, волос, форму и расположение зубов, кожный рельеф кончиков пальцев. Разнояйцевые же близнецы могут быть разного пола и похожи между собой так же, как обычные братья или сестры.

По типу плацентации (вариант прикрепления хориона (плаценты) в полости матки) многоплодная беременность бывает:

- Монохориальной – это означает, что плацента у малышей одна на двоих;
- Дихориальной — у каждого плода имеется своя плацента;
- Моноамниотической — то есть имеется одна плодная оболочка, и дети развиваются в одной амниотической жидкости;
- Диамниотической – вариант, когда у малышей две плодные оболочки и два плодных пузыря.

Типы двойни:

монохориальная моноамниотическая – оба эмбриона находятся в одном амниотическом мешочке и питаются также через одну плаценту;

монохориальная диамниотическая – плацента у таких малышей одна на двоих, но амниотический пузырь у каждого свой;

дихориальная диамниотическая – при таком варианте у каждого крохи своя плацента и свой плодный пузырь.

Диагностика многоплодной беременности.

1. Ультразвуковое исследование. При проведении УЗИ доктор видит в полости матки несколько эмбрионов.
2. Несоответствие размеров матки сроку беременности и их дальнейшее быстрое увеличение, зафиксированное на последующих приемах у гинеколога.
3. Уровень хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) выше при многоплодной беременности. То есть, если концентрация ХГЧ в крови будущей мамы выше нормальной для данного срока беременности, это означает, что она ожидает более одного ребенка.
4. Определение двух точек сердцебиения плода.

Очевидно, если женщина вынашивает не одного, а сразу несколько малышей, ее беременность требует повышенного внимания.

Особенности многоплодной беременности.

1. Объем циркулирующей крови возрастает на 50-60%, повышается потребность в железе и фолиевой кислоте.
2. Рациональное питание — одно из главных условий благоприятного течения и исхода беременности. Важно соблюдать режим питания и правильно распределять продукты на каждый приём пищи. Мясо, рыбу, крупы необходимо включать в рацион завтрака и обеда. На ужин следует употреблять молочно-растительную пищу. Обильный приём пищи в вечернее время, соленая и острая пища не рекомендуется. Питание будущей мамы должно быть достаточно калорийным.
3. При многоплодной беременности женщины чаще жалуются на повышенную утомляемость, одышку, изжогу, запоры и расстройства мочеиспускания.
4. Возрастает количество проводимых ультразвуковых исследований у женщины. Это связано с риском преждевременных родов и невынашивания. Помимо скрининговых исследований, проводят цервикометрию (УЗИ с целью определения длины шейки матки), что позволяет выявить риск невынашивания.

При многоплодной беременности очень распространена истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Она развивается значительно чаще, чем при одноплодной, особенно при наличии тройни и более, что связано с влиянием механического фактора (повышенное давление в полости матки и ее растяжение). Первая цервикометрия проводится на сроке 16 недель беременности. Профилактика преждевременных родов осуществляется ограничением активного образа жизни.

5. Пациентки с многоплодной беременностью требуют особого внимания на протяжении всего срока вынашивания малышей. В связи с этим им необходимо чаще посещать акушера-гинеколога чаще, который будет следить

за состоянием здоровья женщины и физическим развитием ее будущих детей. Особое внимание следует обращать на функции сердечно-сосудистой системы и почек, а также на выявление ранних симптомов гестоза.

Всегда ли кесарево сечение?

Метод родоразрешения, конечно, индивидуален и зависит от многих факторов. Если оба плода находятся в продольном положении и головном предлежании, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья женщины возможно и родоразрешение через естественные родовые пути. В настоящее время чаще проводят плановое кесарево сечение.

Показания к кесареву сечению:

- экстрагенитальные заболевания матери;
- крупные плоды;
- неподготовленность родовых путей;
- поперечное положение плодов;
- тазовое предлежание первого плода;
- гипоксия плодов (плода).

Роды при многоплодной беременности, как правило, проходят на сроке 36-37 недель беременности (при двойне), 33-34 недель (при тройне). Декретный отпуск при многоплодной беременности выдаётся с 28 недель беременности продолжительностью 194 дня.

Итак, вы готовитесь, стать счастливыми родителями сразу двух или более крошек! Очень важно наблюдаться у того акушера-гинеколога, которому доверяете и с кем планировали беременность. Зная особенности вашего организма, доктор подберет оптимальный план наблюдения и обеспечит спокойствие и уверенность, заботу о вашем здоровье и здоровье малышей. Благодаря доверительным отношениям и профессионализму врача, а также своевременности и четкости соблюдения назначений, беременность будет протекать спокойно, и на свет появятся долгожданные, самые любимые малыши!

Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях

Назад к списку статей

8 (843) 202-20-96

Вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости, носит информационный характер. Цены актуальны на дату публикации. Итоговая стоимость медицинских услуг определяется до их оказания и фиксируется в договоре. Дополнительную информацию можно уточнить у наших менеджеров по телефону 8 (843) 202-20-96.

Наши адреса:
Казань, пр. Победы, 152/33
ул. Маяковского, 30
ул. Декабристов, 104
Зеленодольск, ул. Космонавтов, 4

График работы:
Пн.-Пт.: 7.30 - 20.00
Сб.: 9.00 - 18.00
Вс.: 9.00 - 14.00

Оставить благодарность Написать директору

Клиника “9 Месяцев” © Copyrights 2026

Политика конфиденциальности
Пользовательское соглашение

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

ООО Клиника «9 месяцев»
ИНН 1660147957, ОГРН 1101690070789
пр-кт Победы, д.152/33, офис 161,
Казань, Татарстан 420100
8 (843) 207-04-40
Регистрационный номер лицензии Л041-01181-16/00348727 от 20.04.2020г выдана Министерством здравоохранения РТ